

Çocuklarda Fonksiyonel Kabızlık

— Tanı ve Tedavi Algoritması

Rome IV tanı ölçütleri ve ESPGHAN/NASPGHAN 2014 kanıta dayalı kılavuzuna göre; birinci basamak ve pediatri pratiği için basamaklı yaklaşım.

Rome IV

ESPGHAN / NASPGHAN 2014

0–18 yaş

Fonksiyonel (organik olmayan) kabızlık

Tanı ölçütleri (Rome IV)

Çocukların ~%95'inde kabızlık **fonksiyoneldir**. Tanı öncelikle klinik olup, iki ölçüt setinden en az **2 madde** ≥ 1 ay (≥ 4 yaş için ≥ 1 ay, çoğu semptom son 2 ayda) karşılanmalıdır.

0–4 yaş (bebek/erken çocukluk)

≥ 1 ay süreyle, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 defekasyon
- 2 Tuvalet eğitimi sonrası haftada ≥ 1 kirletme (enkoprezis)
- 3 Aşırı gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert-sıkı dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

≥ 4 yaş (çocuk/ergen)

≥ 1 ay, İBS ölçütlerini karşılamayan, aşağıdakilerden ≥ 2

- 1 Haftada ≤ 2 tuvalette defekasyon
- 2 Haftada ≥ 1 kirletme epizodu
- 3 Retansif postür / istemli gaita tutma öyküsü
- 4 Ağrılı veya sert dışkılama
- 5 Rektumda büyük gaita kitlesi
- 6 Tuvaleti tıkayan büyük çaplı dışkı

Tanı için görüntüleme, laboratuvar veya kolonik geçiş çalışması **gerekmez**. Ayrıntılı öykü + fizik muayene (perianal/lomber-sakral bölge + tek seferlik rektal muayene endikeyse) çoğu vakada yeterlidir.

02 Karar akışı

Değerlendir → alarm bulgularını dışla → impaksiyonu boşalt → idame → izlem. Her basamakta ailenin eğitimi ve tuvalet rutini tedavinin temelidir.

BAŞLANGIÇ

Kabızlık şikâyeti ile başvuru

Öykü: başlangıç yaşı, dışkı sıklığı/kıvamı (Bristol), ağrı, kanama, kirletme, tuvalet eğitimi, beslenme, ilaçlar, mekonyum çıkış zamanı, büyüme.

KARAR 1

Alarm bulgusu / organik neden şüphesi var mı?

Bkz. bölüm 03. Mekonyumun >48 saatte çıkışı, kanlı dışkı (fissür yokken), büyüme geriliği, safralı kusma, karın distansiyonu, anormal nörolojik/sakral bulgu...

EVET → organik değerlendirme

HAYIR → fonksiyonel kabızlık

YÖNLENDİRME

Hedefe yönelik tetkik + sevk

Hirschsprung, hipotiroidi, çölyak, anatomik/spinal anomali, inek sütü alerjisi vb. Pediatrik gastroenterolojiye yönlendir; ampirik idameyi geciktirme.

TANI

Fonksiyonel kabızlık kabul et

Aileyi bilgilendir; tuvalet ve beslenme davranışlarını düzenle; tedaviye başla.

KARAR 2

Fekal impaksiyon var mı?

Rektumda kitle, sık kirletme, taşkın (overflow) inkontinans, kısmi tıkanma. Muayene/öyküyle değerlendir.

VAR → önce disimpaksiyon

YOK → doğrudan idame

BASAMAK A

Disimpaksiyon (boşaltma)

Oral PEG 1–1.5 g/kg/gün, 3–6 gün (ilk basamak). Alternatif/başarısızlıkta lavman. İdameye ancak boşaltma sağlanınca geç.

BASAMAK B

İdame tedavisine başla

Boşaltma gerekmiyorsa idame ozmotik laksatifle başla.

BASAMAK C · TEMEL

İdame tedavi — en az 2 ay

PEG 0.4 g/kg/gün (birinci tercih), doz dışkıyı yumuşak tutacak şekilde titre edilir. + düzenli **tuvalet oturma rutini** (öğünlerden sonra 5–10 dk), pozitif pekiştirme, yeterli sıvı ve dengeli lif. Belirtiler **en az 1 ay tamamen düzeldikten sonra** ve tuvalet eğitimi tamamsa kademeli azalt.

KARAR 3

4–8 haftada yeterli yanıt var mı?

YANIT VAR → sürdür + azalt

İZLEM

Devam et, relapsı izle

Tedaviyi erken kesme; nüks sıktır.
Kademeli doz azaltımı, aile eğitimi
pekiştir.

YANIT YOK → yeniden değerlendir

DİRENÇLİ

Uyum? doz? tanı? → sevk

İlaç uyumu ve dozu gözden geçir, ikinci ajan ekle (bkz. tablo). İnatçı vakada organik nedenleri yeniden ara ve **pediatrik gastroenterolojiye yönlendir**.

03 Alarm bulguları (organik neden düşündüröenler)

Bu bulgulardan herhangi biri varsa fonksiyonel kabızlık tanısı ertelenir; hedefe yönelik tetkik ve sevk gerekir.

● Yaşamın ilk **1 ayında** başlayan kabızlık

● Mekonyumun **>48 saatte** çıkışı (Hirschsprung)

● **Büyüme geriliği** / kilo kaybı

● **Safralı kusma**, ciddi karın distansiyonu

● Fissür olmadan **rektal kanama**

● Ailede **Hirschsprung** öyküsü

● Anormal anüs pozisyonu / **anal ton**, gluteal asimetri

● Lombosakral bölgede kıllanma, gamze, sakral çukur → **spinal anomali**

● Alt ekstremitede **nörolojik defisit** / kremaster refleks kaybı

● **Mesane disfonksiyonu**, sürekli idrar kaçırma

● Sistemik: ateş, **çölyak/hipotiroidi** bulguları, aşırı susama

● Cinsel istismar kaygısı / açıklanamayan bulgular

Ozmotik laksatifler (özellikle PEG) hem boşaltma hem idamede birinci basamaktır.

Dozlar yaklaşık olup çocuğa ve yanıtı göre titre edilir.

Disimpaksiyon (boşaltma) — kısa süreli

İLAÇ	DOZ	SÜRE / NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	1–1.5 g/kg/gün	3–6 gün; sıvıyla; ayaktan uygulanabilir
Sodyum fosfat / salin lavman	Yaşa göre	PEG yoksa/yetersizse; süt çocuğunda dikkatli
Bisakodil (rektal) — seçili vaka	5–10 mg	Rutin ilk tercih değil

İdame tedavi — en az 2 ay

İLAÇ	BAŞLANGIÇ DOZU	NOT
PEG 3350/4000 (1. tercih)	0.4 g/kg/gün	Yumuşak dışkıya göre titre; her yaşta güvenli, palatabl
Laktuloz	1–2 g/kg/gün (1–3 mL/kg)	<6 ay / PEG uygun değilse tercih; gaz yapabilir
Sıvı parafin (mineral yağ)	1–3 mL/kg/gün	>1 yaş; aspirasyon riski olanda kaçın
Magnezyum hidroksit	Yaşa göre	Alternatif ozmotik; böbrek yetmezliğinde dikkat
Bisakodil / senna (ek uyarıcı)	Yaşa göre	Ozmotik yetersizse kısa süreli ekleme (kurtarma)

Süt çocuğunda (<6 ay) laktuloz veya ozmotik ilk seçenektir; ayrıca laktuloz/sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) faydalıdır. **İnek sütü proteini alerjisi** düşünülen dirençli vakalarda 2–4 haftalık eliminasyon denenebilir.

05 Davranışsal ve beslenme desteği

Tuvalet rutini & davranış

- Öğünlerden sonra günde 2–3 kez, **5–10 dk** tuvalette oturma (gastrokolik refleks).
- Ayakların desteklendiği **uygun postür** (basamak/tabure).
- Dışkı günlüğü ve **pozitif pekiştirme** (ödül/yıldız çizelgesi).
- Cezalandırıcı tutumdan kaçın; tuvalet korkusunu azalt.
- Aile eğitimi: kabızlık kronik seyreder, tedavi **aylar** sürer.

Beslenme

- **Yeterli sıvı** ve yaşa uygun dengeli **lif** alımı (normalin üstüne çıkarmak gerekmez).
- Sorbitol içeren meyve suları (kuru erik, armut, elma) süt çocuğunda yardımcı.
- **Rutin olarak** prebiyotik/probiyotik önerilmez (yeterli kanıt yok).
- Aşırı inek sütü tüketimini gözden geçir.
- Diyet tek başına tedavi değildir — laksatifin yerini tutmaz.

Tedavinin süresi: İdame en az **2 ay** sürdürülür; belirtiler **en az 1 ay tam düzeldikten** ve tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra doz kademeli azaltılır. Erken kesme en sık nüks nedenidir.

06 Pediatrik gastroenterolojiye ne zaman sevk?

Herhangi bir **alarm bulgusu**

Optimal tedaviye rağmen **dirençli** seyir

Tanıda belirsizlik / organik şüphesi

Hirschsprung şüphesi (mekonyum gecikmesi)

Ağır enkoprezis / psikososyal etki

Rektal prolapsus, anal patoloji

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç dozları uygulamadan önce doğrulanmalıdır. Yayınlanmış tam metin kılavuzlara başvurun.

Kaynaklar

1. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, ve ark. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: Evidence-Based Recommendations From ESPGHAN and NASPGHAN. *JPGN*. 2014;58(2):258–274.
2. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1456–1468.
3. Benninga MA, Faure C, Hyman PE, ve ark. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler (Rome IV). *Gastroenterology*. 2016;150(6):1443–1455.